

标注手册 (Codebook)

发布说明：版本号V2.0，发布原因：依据首轮双标注+仲裁意见修订，全部改动见文末《v2.0 修订记录》，阈值类规则**含等于**。发布日期 2026-09-03，**补发用于标注员 A1/A2 间隔≥3 天的重复标注**。
原则：重复标注只按本手册规则标注，请标注员不要再使用或者回忆v1.0版本标注手册。

域① H社区ECG（输入：ecg_text，一段结论文本）

输出列（多标签，各0/1）：

列	定义	判定规则
ecg_normal	正常心电图	含"正常心电图/大致正常/未见明显异常/正常范围"，且无任何下述异常
ecg_af	房颤/房扑	房颤、心房颤动、心房扑动、房扑（不含"窦性"）
ecg_pac_pvc	早搏	早搏、期前收缩、过早搏动（房性/室性均标1，无需区分）
ecg_stt	ST-T/缺血	ST-T改变、ST段（抬高/压低）、T波（低平/倒置/高尖）、心肌缺血； "未见ST-T改变"=0
ecg_avblock	房室传导阻滞	一/二/三度房室传导阻滞、I /II/III度AVB
ecg_bbb	束支/室内阻滞	左/右束支传导阻滞、分支阻滞、室内传导阻滞
ecg_rate	心率异常	窦性心动过速（>100）、窦性心动过缓（<60）；窦性心律（60-100）不算； v2：房颤/房扑伴快速心室率（"快速型/心室率快"）=1；非窦性心动过速（如非阵发性交界区心动过速）不算
ecg_srirr	窦性心律不齐	窦性心律不齐/窦性心动不齐（含错别字变体）
ecg_axis	电轴/转位/低电压	电轴左偏/右偏、顺/逆钟向转位、低电压
ecg_qwave_mi	异常Q波/陈旧性心梗	异常Q波、病理性Q波、陈旧性下壁/前壁梗死
ecg_other	其他器质异常	预激、逸搏、起搏器、房室分离、肥大/肥厚、紊乱性心律等； v2：窦房阻滞、房室连接处（交界区）心动过速列入本列；"左心室（高）电压"不算（属axis低电压同类描述，无器质含义）；"早期复极（综合征）/ST段J点抬高提示早期复极"属正常变异，不计入本列

列	定义	判定规则
ecg_unreadable	无法判读	文本缺失/×/弃检/拒检/图像质量差；v2：文本与所属域不符（错配，如腹超文本出现在心电图基）按无法判读=1，并在note反馈数据源

边界例：

- "窦性心律，一度房室传导阻滞，部分导联ST-T改变" → avblock=1, stt=1
- "未见ST-T改变，心电图大致正常" → normal=1
- "窦性心动过缓伴不齐（58bpm）" → rate=1, srirr=1
- "电轴不偏" → 不算axis异常

域② PG心脏echo（输入：echo检查所见全文）

输出列：

列	定义	判定规则
echo_normal	结构功能无异常	无任何下述异常，且瓣膜仅"未见/无"；v2：心包积液（心包腔液性暗区）、心腔内性质待定的异常回声属结构异常 → echo_normal=0（不属既列变量时 flag=1 说明）
echo_variant	少量/轻度返流	仅"少量/轻度/轻微"返流，无结构异常
echo_lvh	左室肥厚	室间隔或左室后壁厚度≥12mm（含等于，实测12mm即判1），或明确写"室间隔/左室壁增厚"；二尖瓣/主动脉瓣增厚不算
echo_la_dilate	左房增大	左房内径≥40mm（含等于，实测40mm即判1，含前后径/上下径任一达阈值），或明确"左房增大/扩大"
ef_value	EF数值	抽取"射血分数（EF）：67"中的数字；无则空
ef_abnormal	EF<50	1/0
reflux_grade	返流分级	none/trace_mild(少量-轻度-轻微)/moderate(中量)/severe(大量)；"未见返流"=none
echo_rhythm	节律异常	房颤/早搏/起搏/传导阻滞等任一
echo_unreadable	无法判读	同上

边界例：

- "二尖瓣后叶增厚、回声增强" → 不算LVH（瓣膜增厚），若有中度返流则reflux=moderate
- "左房内径约41mm，余房室大小正常" → la_dilate=1
- "肝实质细密"出现在echo文本中 → 忽略（肝所见不属于echo域）

域③ 腹部超声（输入：超声所见文本 + 主检结果，两列分别标注后以超声所见优先）

输出列：

列	定义	判定规则
us_fatty	脂肪肝	明确"脂肪肝"；描述式阳性：实质回声细密(增强)+后方衰减+管道欠清 三要素≥2即判阳性
us_fatty_degree	分度	轻/中/重（原文出现才标，否则空）
us_hepatic_other	其他肝病	血吸虫性肝病、肝囊肿(>10mm)、血管瘤、占位、肝硬化；v2：肝内未定性结节/占位 (>20mm) 计入本列；肝内钙化灶计入本列
us_gallstone	胆系	胆囊/胆管结石、息肉(记note大小)；v2：胆管结石明确计入本列
us_kidney_cyst	肾囊肿	含"左/右/双"记note
us_unreadable	无法判读	×/弃检/无文字
main_discrepant	主检与超声不一致	主检结果有/无脂肪肝与本次超声所见矛盾时=1；v2：主检脂肪肝结论引自其他影像（CT/MRI附见）而本次超声未见 → 不算矛盾（=0，可flag说明）

边界例：

- "肝实质回声细密增强，后方轻度衰减，管道结构欠清" → fatty=1（三要素3/3）
- "肝实质回声呈网络状、门脉管壁增厚（血吸虫肝病）" → fatty=0, hepatic_other=1
- "回声不均匀"单独出现 → 不判脂肪肝，flag=1

通用规则

- 否定优先：先扫"未见/无明显/无/不厚/不增宽"及其后8字窗口，命中则该异常=0
- 多标签并存：一个文本可同时标多个异常列
- 不确定：flag=1 + note 写明原因（每份标注flag率预期<5%；>10%请停下反馈手册）
- 速度：ECG目标~40s/份，echo/腹超~90s/份；不追求零犹豫，仲裁机制兜底
- 盲法：标注时不得查看LLM/词典的预填结果（工作簿中不提供）

v2.0 修订记录（2026-09-03，依据首轮双标注+仲裁裁决）

#	域	修订内容	依据
1	ECG	"早期复极（综合征）/ST段J点抬高提示早期复极"属正常变异，不计入 ecg_other	仲裁建议①
2	ECG	"左心室（高）电压"不计入 ecg_other；窦房阻滞、房室连接处（交界区）心动过速列入 ecg_other	仲裁建议②

#	域	修订内容	依据
3	ECG	ecg_rate: 房颤/房扑伴快速心室率（快速型）=1；非窦性心动过速（如非阵发性交界区心动过速）不计	仲裁建议③
4	ECG	文本与所属域不符（如腹超文本进入心电图基）按 ecg_unreadable=1 并反馈数据源	仲裁建议④
5	echo	心包积液（心包腔液性暗区）属结构异常；心腔内性质待定异常回声按结构异常处理（均使 echo_normal=0）	仲裁建议⑤
6	腹超	肝内未定性结节占位（>20mm）、肝内钙化灶计入 us_hepatic_other；胆管结石明确计入 us_gallstone；脂肪肝结论引自其他影像（CT/MRI附见）而本次超声未见时不判 main_discrepant	仲裁建议⑥
7	echo	阈值含等于 ：室间隔/左室后壁厚度=12mm、左房内径=40mm 均判阳性（首轮15例 echo 分歧全部源于边界值，仲裁均判"达阈值即阳性"）	仲裁裁决
8	ECG	"早期复极"与 ecg_stt 的关系本轮未作裁定，暂维持 v1 字面口径；如遇请 flag	保留事项

重标范围（课题组决定 C 方案）：仅 echo_lvh、echo_la_dilate 两变量依 v2.0 重标（ECHO_PG 全 300 份，A1/A2 双人独立）；ecg_other 与 main_discrepant 的 rater-vs-final F1 缺口如实报告，不重标。